DOI：10.13193/j.archtcm.2004.12.130.guoxj.065

悬钟穴的应用及定位考证

郭 向 军 指 导：裴景春教授
（辽宁中医学院，110032，辽宁沈阳//男，1972年生，主治医师，2002级硕士研究生）

关 键 词：悬钟穴； 应用； 研究
中图分类号：R245.01 文献标识码：A 文章编号：1009－5276(2004)12－2288－03

悬钟穴出自《针灸甲乙经》，别名绝骨，属足少阳胆经。其临床应用范围相当广泛。笔者从以下三个角度加以总结：

1 独穴（主穴）运用

崔嵩山[1]采用悬钟穴治疗落枕。患者取端坐位，取病侧悬钟穴，刺入穴位得气后，留针10～20min，期间运针一次，针后患者症状明显改善或消失。个别病例，可局部辅以按摩手法，一般一次可治愈。有关悬钟穴治疗落枕的病例很多。柴恒彬[2]采用巨刺方法，即左病针右，右病针左。朱兴中[3]配阿是穴，姜守信[4]配合局部按摩，另外肖明静[5]和朱红影[6]采用指针的方法。其他学者也有报道，这里不一一列举。总之，各家的疗效较好，治法大同小异。只是取穴位置略有不同，见后文论述。

郭学梅[7]以绝骨穴为主治疗偏头痛。方法：治疗组取患侧绝骨穴，配阿是穴，对照组取悬颅、率谷、风池、阿是。患者侧卧，进针，用提插手法，若针感差者可配1～2个阿是穴。留针均为30min，每10min行针一次；1天1次，10次为1疗程。结果：治疗组有效率为100%，对照组有效率为83%，经统计学处理有显著性差异。

赵臣来[8]独取绝骨治疗急性腰扭伤。方法：患者取合适体位，快速进针，缓慢捻转，得气后行凤凰展翅之法[9]；并嘱患者保护腰部。50例病例，治愈49例，好转1例。其中针刺一次痊愈31例，占62%，两次痊愈16例，占32%，针五次痊愈2例，占4%。一例经五次治疗未愈，改用他法治疗。

赵海音[10]采用巨刺绝骨穴治疗下肢截肢残端痛，取得较好效果。取健侧绝骨穴，进针，得气后，快速捻转1～2min，每10～15min运针一次，留针45min，隔日1次，10次为一疗程。留针期间，嘱患者在针感强时做膝关节的屈伸运动。结果：显效〔疼痛完全消失或基本消失〕1例，有效〔疼痛明显减轻〕15例，无效〔一个疗程，疼痛无明显的缓解〕0例。

胡海燕[11]总结出悬钟穴可治下肢痿痹，中风后遗症，胁痛，肩周炎，偏头痛，落枕和妇儿疾病，并附有案例。

2 双穴应用

蒋海英[12]采用针刺悬钟透三阴交治疗肩周炎。方法：取患肩同侧悬钟穴，进针至三阴交以不透出皮肤为度。强刺激提插捻转，同时嘱患者作上举、外旋、后伸等动作，得气后留针30min，每10min行针一次，1天1次，3次为1疗程。结果：经过1～2个疗程，60例中痊愈48例，占80%；显效7例，占11.7%；有效4例，占6.6%；无效1例，占1.7%。总有效率为98.3%。郑建宁[13]采用三阴交透刺悬钟穴治疗痛经。56例，年龄最小16岁，最大30岁；未婚46例，已婚10例；病程最短半年，最长15年。方法：从三阴交透刺悬钟穴，行捻转泻法，得气后留针30min，1个周期为1个疗程。结果：痊愈35例，占62.5%；显效19例，占33.9%；无效2例，占3.6%。李义蓉[14]采用三阴交及悬钟治疗急性腰扭伤。方法：患者坐位，取患者双下肢三阴交及悬钟穴针刺并留针，然后扶患者慢慢站立做躯干的环转动作2～5min，直至腰部疼痛减轻或消失。1天1次，连续治疗2～3次。结果：30例中，28例痊愈，占93.3%；2例好转，占6.6%。陈随社[15]采用悬钟穴治疗急性腰扭伤。方法：患者取坐位，快速进针，反复提插，弹击针头，得气后，嘱患者慢慢站起，两手抱头，前后左右缓慢摆动腰部。结果：94例患者，痊愈75例，显效10例，好转9例，总有效率为100%。杨志新[16]提及悬钟与三阴交配合治疗脚癣、癔病性瘫痪、白细胞减少症、红斑性肢痛、头痛、偏头痛、痛经、鼻衄、落枕等病证，疗效都颇为满意。邓柏颖[17]作了灸足三里和悬钟治疗高脂血症的疗效观察。方法：取穴悬钟、足三里。材料：麦粒样大小圆锥形艾炷。医用胶布。穴位表面涂抹大蒜汁（或芦荟汁），将艾炷置于穴位上，点燃，待艾炷燃尽，去灰，贴上胶布，并于灸后2周内酌进豆类等发物促灸疮早发。若半月内胶布脱落需重新贴上。对灸疮化脓后局部反应明显者，给予针灸处理（炎性化脓者除外）。每次每穴只灸1壮，1次为1疗程。观察时限为60天。治疗后TC、TG、LDL较治疗前明显改善，但HDL变化不明显。参照中华人民共和国卫生部制定颁发的《中药新药临床指导原则》[18]中的疗效标准，48例中，临床控制12例，显效19例，有效16例，无效1例，总有效率为97.9%。潘小霞[19]作了瘢痕灸足三里、绝骨延缓衰老的临床观察。其方法与邓柏颖[18]基本相同，只是在治疗时间上有所需求。一年之中于立春、立夏、立秋、立冬、春分、夏至、秋分、冬至八正之气日施灸，取双侧足三里、绝骨穴，每穴1壮，每年施灸2～3次。结果：显效（衰老见症积分值较治疗前下降大于2/3）11例；有效（衰老见症积分值较治疗前下降在1/3和2/3之间）32例；无效（衰老见症积分值较治疗前下降小于1/3）7例。总有效率为81%。黄静[20]采用瘢痕灸足三里、悬钟治疗膝关节炎。方法：治疗组方法与邓柏颖[18]基本相同；对照组，取患侧足三里、阴阳陵泉、内外膝眼、梁丘、血海、委中，每次选3～5穴，针刺得气后，按6805－2型电针机，连续波形，通电以患者耐受为度，留针

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

25min，每日 1 次，逢周日休息。治疗 1 月后统计疗效。经对比分析，治疗组治愈率为 48%，优于对照组 20%；对治疗组好转及无效的患者施第 2 疗程。总结，治愈率提高至 72%，有效率 96%。随访半年，治疗组复发率为 4%，愈显率降到 68%。

3　与其他穴位配合应用

王选伟[21]采用针刺法治疗震颤麻痹。方法：取百会、太冲穴，针刺以泻法；少海、外关、合谷、绝骨穴，针刺以补法。针刺 10 次为 1 疗程，停针 3～5 天，再行治疗。疗效标准：痊愈：震颤、肌肉强直、运动减少三联征全部消失；好转：上述三联征及体征有很大改善，生活做到自理；无效：上述三联征及体征没有改变。结果：40 例中，痊愈 24 例，占 60%，好转 14 例，无效 2 例，总有效率为 95%。

李素仁[22]采用针刺法治疗痛风。方法：取穴：阳陵泉，足三里。病变部位在内踝、跖趾、踝趾关节者配三阴交、太溪、太冲、太白、隐白、大敦；病变部位在外踝、小趾、无名趾跖趾关节者，配绝骨、昆穴、丘墟、足临泣、侠溪、足窍阴、至阴。针刺用捻转泻法，得气后留针 30min，每隔 10min 行针 1 次，每日针 1 次，7 天为 1 疗程。治疗时间最短者 3 天，最长者 1 个月。五十例中，1 周内治愈者〔病状体征消失〕18 例，两周内治愈者 21 例，1 月内治愈者 11 例。其中 47 例治愈后至今未复发；3 例半年左右复发经再次针刺治疗，一年多未复发。

杨波[23]采用烧山火针法治疗雷诺病。方法：患者仰卧，取双侧曲池、外关、阳陵泉，以烧山火手法行针 2～3min，患者自觉针下有温热感为度。后于外关、绝骨，行平补平泻手法，留针 40min。其间行针 1 次。刺后无温热感者配合温针灸。每日 1 次。15 例患者中，首针产生温热感 10 例，第 2 次针后均有温热感产生，所有患者均在 3 次治疗后症状明显好转，5～13 天均获痊愈，平均为 8 天。孙阳[24]采用巨刺法治疗脑梗塞。方法：巨刺组：主穴取百会、风池、肩骨、曲池、合谷、阳陵泉、足三里、悬钟、解溪。快速进针，留针 30min，每日针 1 次，10 次为 1 疗程。上下两疗程间隔两天，平均治疗 3 个疗程。对照组取瘫肢腧穴，刺法同巨刺组，平均治疗 3 个疗程。结果：巨刺组有效率为 95%，对照组有效率为 80%，经统计学处理有显著性差异。罗国礼用电针治疗格林巴氏综合征。方法：取穴分两组，一组为新设、肾俞、肩骨、曲池、合谷、环跳、阳陵泉、绝骨。另一组为大杼、大肠俞、手三里、支正、外关、髀关、丰隆、足三里、解溪。每一次选用一组，两组交替使用，针刺得气后，接 6805 型电针仪，电量以病人能耐受为度。选择断续波，每 min18～20 次，通电 30min。每日 1 次，20 次为 1 疗程，不愈者停针 7 天，继续治疗。结果：37 例中，治愈 18 例，占 49%，显效 11 例，占 30%，进步 6 例，占 16%；无效 2 例，占 5%，总有效率为 95%。

丁金榜采用针刺法治疗脑挫裂伤。方法：肢体瘫痪者主穴取足运感（双）、运动区（上 1/5 或中 2/5）。上肢瘫痪加肩三针、曲池、合谷、手三里、外关、合谷透后溪及阿是穴；下肢瘫痪加阳陵泉、足三里、绝骨等。若有意识障碍，言语障碍，面瘫等随证加减。1 天 1 次，头针和体针同时或交替使用，体针用平补平泻法或补法。10 次为 1 疗程，疗程间休息 1 周。结果：治疗的 10 例中，1 例好转，1 例遗有创伤性精神病，余均获痊愈。周健伟取穴环跳、阳陵泉、悬钟治疗梨状肌综合征。方法：取环跳，快速刺入，候气，施雀啄灸法 2～3 次，勿捻转。阳陵泉、悬钟直刺，得气后施捻转补泻手法。留针 30min，15min 运针 1 次，1 天 1 次，12 次为 1 疗程。疗程间休息 3 天，继续治疗。结果：治愈 55 例，占 73.33%；有效 18 例，占 24%；无效 2 例，占 2.67%，总有效率为 97.33%。

4　悬钟穴的定位

《中华人民共和国国家标准经穴部位》规定：悬钟穴在小腿外侧，外踝上 3 寸，腓骨前缘。近年来有关悬钟穴的报道中，少有人提及其定位。但柴恒彬[2]、朱兴中[4]、肖明静[5]等人在各自的报道中明确提出悬钟穴位于腓骨后缘。周健伟对此从悬钟穴与少阳经的联系，从文献记载，从解剖学分析，从临床对比中观察四个角度考证，认为悬钟穴定位于腓骨前缘较为妥当，并提出外踝上 3 寸排骨后缘点与膀胱经联系密切。

5　结　语

悬钟穴，为八会穴之髓会，具有行气血，通经络，填精益髓之功效。其独穴和双穴的临床应用，体现了中医理论中交经缪刺，上病下取的原则，在与其他穴配合应用中突出了其髓之会穴的整体调节作用。

悬钟穴的临床应用，在古代文献中多有记载，如《针灸大成》和《千金方》中均有记载悬钟穴主治“颈项强”的条目；《医学入门》和《标幽赋》中记录了悬钟穴治疗下肢痿痹；在《针灸捷要》中，记录了悬钟穴治疗妇科和胁痛证等。所以在现代临床应用过程中，深入挖掘和整理古代文献尤为重要。在悬钟穴的现代研究中，关于其为髓之会穴主治作用的机理，研究内容尚显不足。

参考文献

〔1〕崔嵩山.新疆中医药，1994，1：24

〔2〕柴桓彬，王芝兰.针刺绝骨穴治疗落枕〔J〕.针灸临床杂志，2002，5：42

〔3〕朱兴中.绝骨穴配冏是穴治疗落枕 40 例〔J〕.陕西中医，1995，11：509

〔4〕姜守信.深刺悬钟穴配合按摩手法治疗颈部软组织损伤 80 例〔J〕.针灸临床杂志，1998，9：36

〔5〕肖明静.按揉悬钟穴可治落枕〔J〕.气功，1999，7：320

〔6〕朱红影，张隽，王月兰.指针悬钟穴对落枕的即时效应观察〔J〕.针灸研究，1998，3：204

〔7〕郭学梅，郝俊卿.针刺绝骨穴治疗偏头痛 40 例〔J〕.中医药研究，1997，2：30

〔8〕赵臣来，郭加利.独取绝骨穴治疗急性腰扭伤 50 例〔J〕.针灸临床杂志，2003，3：37

〔9〕张晋.针灸大成校释〔M〕.北京：人民卫生出版社，1984，483

〔10〕赵海音.巨刺绝骨穴治疗下肢截肢后残肢端痛 6 例〔J〕.湖北中医杂志，1992，封 2

〔11〕胡海燕.悬钟穴的临床应用〔J〕.湖北中医杂志，2002，8：47

〔12〕蒋海英.针刺悬钟透三阴交治疗肩周炎 60 例〔J〕.现代中西医结合杂志，1999，12：2018

（下转第 2295 页）

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（上接第 2289 页）

〔13〕郑健宁. 三阴交透刺悬钟穴治疗痛经 56 例〔J〕. 新中医, 1997, 5: 25
〔14〕李义蓉, 田玲. 针刺三阴交及悬钟治疗急性腰扭伤〔J〕. 四川中医, 2000, 4: 56
〔15〕陈随社, 石泽兴. 针刺昆仑悬钟穴治疗急性腰扭伤 94 例〔J〕. 陕西中医, 1995, 8: 366
〔16〕杨志新. 相对穴位的临床应用〔J〕. 中国临床医生, 2003, 6: 50
〔17〕邓柏颖, 谢感共, 罗本华. 功能保健灸治疗高脂血症 48 例疗效观察〔J〕. 新中医, 2002, 9: 48
〔18〕中华人民共和国卫生部·中药新药临床研究指导性原则第 2 辑, 1995, 171
〔19〕潘小霞. 瘢痕灸延缓衰老的临床观察〔J〕. 上海针灸杂志, 1999, 3: 3
〔20〕黄静. 瘢痕灸治疗膝关节炎 50 例疗效观察〔J〕. 针灸临床杂志, 2002, 3: 44
〔21〕王选伟. 针刺治疗震颤麻痹 40 例〔J〕. 陕西中医, 1994, 4: 176
〔22〕李素仁. 针刺治疗痛风 50 例〔J〕. 四川中医, 1996, 11: 53
〔23〕杨波. 烧山火手法治愈雷诺病 15 例〔J〕. 河南中医, 1997, 3: 186
〔24〕孙阳. 巨刺法治疗脑梗塞 40 例〔J〕. 黑龙江中医药, 2000, 01: 57

表 3　IFN－γ 生成水平测定结果(pg/ml)

Table 3 Determination of IFN－γ concentration

	只	A($\bar{x}\pm s$)	P
实验组	12	1916.6±234.2	0.043
对照组	12	720.3±197.5	

小鼠血清中 IL－2 生成水平测定结果　实验组显著高于对照组。详见表 4。

表 4　IL－2 生成水平测定结果(pg/ml)

Table 4 Determination of IL－2 concentration

	只	A($\bar{x}\pm s$)	P
实验组	12	2827.4±457.3	0.018
对照组	12	692.3±122.2	

3　讨　论

茶叶具有广泛的药理作用，具有抗癌、抗氧化、免疫调节等作用，已被较多的研究所证实，但是其关于免疫调节的作用及调节途径及机理尚有许多未解决的问题，特别是其是否提高机体对某些特异性抗原应答的免疫水平以及有关对细胞因子的影响尚没有研究报告。笔者采用颗粒性抗原(SRBC)和可溶性抗原(卵清蛋白)分别激发小鼠的免疫系统为基础免疫，然后用茶叶多糖灌服小鼠，再用相同抗原激发机体免疫系统。发现灌服茶叶多糖小鼠免疫应答水平均高于对照组(见表 1、表 2)。说明口服茶叶多糖可以增强机体免疫应答，也说明茶叶多糖是调节免疫应答水平的重要物质。

笔者同时还对小鼠受抗原激发后，IL－2、IFN－γ 水平进行检测。一般认为，IL－2 是一种广谱的细胞因子，对调节整体的免疫水平(体液免疫、细胞免疫)均具有重要的调节作用；而 IFN－γ 主要由 T 细胞产生，是调节细胞免疫的重要因子。本文检测结果，两种细胞因子均明显升高(见表 3、表 4)。提示灌服茶叶多糖小鼠的细胞免疫水平可能有相应提高。

本文未采用免疫低下小鼠模型，即得到茶叶多糖提高小鼠免疫水平的结果，说明茶叶多糖具有较强的免疫调节作用，并且可以作为免疫治疗药物使用。茶叶多糖具有较大的、潜在的应用价值。茶叶多糖作用于机体粘膜系统，刺激粘膜系统产生细胞因子，如 IL－2、IFN－γ 等，从而上调机体免疫水平，这可能是茶叶多糖调节免疫系统的有效途径。

参考文献

〔1〕Huang Guikuan, Li Yi, Xie Rongfang, et al. Experimental study on extraction of polysaccharide from green tea〔J〕. Acta Academiae Medicinae Guangxi(广西医科大学学报), 1996, 13 (4): 43～45
〔2〕Zhang Yunfang, Jin, Yong, Li Jun et al. Effects of TPS on immune index of rats with adjuvant arthritis〔J〕. Acta Universitatis Medicinalis Anhui (安徽医科大学学报), 2000, Feb, 35 (1): 27～29
〔3〕Fang Jiping. Separation, purification of polysaccharides and their purity assay and molecular weight determination〔J〕. Pharmacol Bull(药学通报), 1981, 19(10): 622～625
〔4〕Yang Tingbin. Practical Immunology〔M〕. Changchun: Publishing House, 1994, 405
〔5〕Liu Hui. Experiment guide for clinical immunology and immunological diagnosis〔M〕. Beijing: People's Medical Publishing House, 2002, 17

Effects of Tea Polysaccharide on Immune Response of mice after Antigen Stimulation and their Possible Mechanisms

Abstract: *Objective*: To discuss the effects of tea polysaccharide on immune response of mice and the underlying mechanism. *Methods*: Sheep red blood cell (SRBC) and ovalbumin were employed as antigens to be injected to mice respectively. Then the mice received the same stimulus were divided into two groups; mice of the experiment group were administered with tea polysaccharide while mice of the control group were normal saline instead. After the secondary immunization, the level of corresponding antibody and the concentration of serum IL－2、IFN－γ were determined. *Results*: The levels of antibodies (anti－SRBC and anti－ ovalbumin) and cytokines (IL－2 and IFN－γ) in experiment groups were all significantly higher than those of control groups($P<0.05$). *Conclusion*: Tea polysaccharide can intensify the immunity of mice.

Keywords: tea polysaccharide; immunity; IL－2; IFN－γ

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net